Centre hospitalier de Valmorin
Pôle cœur-vaisseaux · Service de cardiologie

12, avenue des Tilleuls · 41290 Valmorin
Secrétariat : 02 54 71 30 66
cardiologie@ch-valmorin.example

Compte rendu d'hospitalisation

Patiente	Mme Odile FERRAND	Née le	17/03/1949
Séjour	du 02/10/2026 au 09/10/2026	Unité	Soins intensifs puis 3e étage
Médecin traitant	Dr Paul Ricaud, Saint-Aignan	N° de séjour	2026-11873

Motif d'hospitalisation

Mme Ferrand, 77 ans, est adressée par le SAMU pour une douleur thoracique constrictive apparue au repos. L'électrocardiogramme initial montre un sous-décalage du segment ST en territoire latéral.

Antécédents

- Hypertension artérielle traitée depuis 2011
- Diabète de type 2 sous antidiabétiques oraux
- Cholécystectomie en 1998
- Allergie déclarée à la pénicilline

Histoire de la maladie

La douleur a débuté le matin du 2 octobre, au réveil, avec une irradiation vers le bras gauche. La patiente a pris son traitement habituel sans amélioration et a appelé le centre 15 une heure plus tard. À l'arrivée, elle était consciente, eupnéique, avec une pression artérielle de 158/92 mmHg.

Examens complémentaires

Biologie

Paramètre	Résultat	Unité	Valeurs de référence
Troponine T hs (H0)	**86**	ng/L	< 14
Troponine T hs (H3)	**212**	ng/L	< 14
Créatinine	94	µmol/L	45 – 90
Hémoglobine	12,8	g/dL	12,0 – 16,0
HbA1c	**7,9**	%	< 6,5
LDL-cholestérol	1,42	g/L	objectif < 0,55
Potassium	4,1	mmol/L	3,5 – 5,0

Imagerie et explorations

La coronarographie réalisée le 3 octobre retrouve une sténose serrée de l'artère circonflexe moyenne. Une angioplastie avec pose d'un stent actif a été effectuée dans le même temps, sans complication. L'échocardiographie de contrôle montre une fraction d'éjection du ventricule gauche à 52 %.

Évolution dans le service

Les suites de l'angioplastie ont été simples et la patiente n'a plus présenté de douleur. Le point de ponction radial est propre, sans hématome. Une hypoglycémie modérée le 5 octobre a conduit à adapter le traitement antidiabétique. La reprise de la marche a été progressive avec le kinésithérapeute du service.

Traitement de sortie

Médicament	Posologie	Durée
Acide acétylsalicylique 75 mg	1 comprimé le midi	Au long cours
Ticagrélor 90 mg	1 comprimé matin et soir	12 mois, puis réévaluation
Atorvastatine 80 mg	1 comprimé le soir	Au long cours
Bisoprolol 2,5 mg	1 comprimé le matin	Au long cours
Ramipril 5 mg	1 gélule le matin, contrôle de la kaliémie à J10	Au long cours
Metformine 1000 mg	1 comprimé matin et soir	Au long cours

Consignes à la patiente

1. Ne jamais interrompre le ticagrélor ni l'aspirine sans avis du cardiologue.
2. Appeler le 15 en cas de nouvelle douleur thoracique de plus de dix minutes.
3. Réaliser une prise de sang à J10 : créatinine et potassium.
4. Participer au programme de réadaptation cardiaque proposé à partir du 20 octobre.
5. Reprendre la conduite automobile après une semaine, sauf avis contraire.

Suivi

Une consultation de cardiologie est programmée dans trois mois avec une épreuve d'effort. Le médecin traitant est invité à renforcer le suivi du diabète et à viser un LDL-cholestérol inférieur à 0,55 g/L. Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Dr Hélène Marchais

Praticien hospitalier, cardiologie